

폐암 진단 첫 30일

조직형 · 유전자검사 · 치료 순서 이해

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 02

완전판 · 2026년 10월 개정 2판

폐암 치료는 ‘조직형’과 ‘유전자 결과’를 확인한 뒤에 정해집니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Non-Small Cell Lung Cancer / Small Cell Lung Cancer, Version 9.2026(비소세포 기준) 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 책의 사용법

이 책은 처음부터 끝까지 읽는 책이 아닙니다. **지금 내 상황에 필요한 장만 펴서 쓰는 책**입니다.

지금 내 상황	먼저 펼 곳
방금 진단을 들었고 머리가 하얗다	1장 「먼저 구분하세요」 → 「진단 뒤 72시간」
몸에 이상 신호가 있다	「기다리지 않는 신호」 (응급 상자)
다음 주에 진료가 잡혀 있다	해당 치료 장 + 워크북 「진료 기록지」
검사 결과지를 받았다	PART 1의 병리·검사·병기 장
돈·보험·회사가 걱정이다	PART 5 「돈 · 서류 · 제도」
마음이 무너질 것 같다	PART 4 「마음 돌보기」
가족으로서 무엇을 해야 할지 모르겠다	PART 4 「보호자에게」

각 장의 구성은 같습니다.

- **30초 요약** — 바쁠 때는 이 상자만 읽어도 됩니다.
- **본문** — 왜 그런지, 무엇을 확인하는지.
- **오늘 물어볼 질문** — 진료실에 가져갈 질문은 장마다 3개 이내로 골랐습니다.
- **기록칸** — 들은 내용을 그 자리에서 적습니다. 보호자가 적어도 좋습니다.
- **🆘 응급 상자** — 기다리지 말고 연락해야 하는 신호입니다.

이 책의 표시:  확정된 정보 ·  검사·결정 대기 ·  아직 모름/확인 필요.
색이 아니라 기호로 구분했으니 흑백으로 인쇄해도 그대로 쓸 수 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 영상 의심과 조직 확진, 비소세포와 소세포

30초 요약

- CT에서 "폐암 의심"은 아직 확진이 아닙니다. **조직(또는 세포)검사**로 확진합니다.
- 폐암은 크게 **비소세포폐암(약 85%)**과 **소세포폐암**으로 나뉘고, 치료 경로가 완전히 다릅니다.
- 비소세포폐암은 **유전자(드라이버 변이)·PD-L1 결과**가 치료를 바꿉니다. 수술 예정인 분도 마찬가지입니다.

결과지에 적힌 말	뜻	볼 곳
결절, 간유리음영(GGO), 부분고형	영상 소견. 암일 수도, 아닐 수도	담당의 확인
선암(adenocarcinoma)	가장 흔한 비소세포폐암. 유전자 변이가 흔함	4·5장
편평상피세포암	비소세포폐암. 흡연과 관련이 많음	4·5장
NSCLC, NOS	검체가 작아 세부형을 정하기 어려움	추가 검사 상의
소세포폐암(SCLC)	빨리 자라는 편. 항암·방사선 중심	10장 먼저
상피내선암·최소침습선암	아주 초기 형태	의료진에게 의미 확인

소세포폐암이라면: 2장(응급) → 10장(소세포폐암 지도) → PART 6(질문·요약)을 먼저 보세요. 유전자검사 장(5장)은 대부분 해당하지 않습니다.

흡연하지 않았는데 왜? 비흡연자 폐암, 특히 동아시아 여성의 선암에서는 EGFR 같은 유전자 변화가 흔히 발견됩니다. 대부분 한 가지 원인을 특정할 수 없고, **당신의 잘못이 아닙니다.** 흡연했던 분도 마찬가지로, 지금 중요한 것은 원인이 아니라 계획입니다.

첫 30일의 지도

순서	할 일	시기
①	조직 확진·조직형	Day 0-7
②	병기 검사(PET/CT, 뇌 MRI, 필요 시 EBUS)	Day 3-14
③	유전자(NGS)·PD-L1 결과	Day 7-21
④	수술 / 방사선·항암방사선 / 전신치료 경로 결정	Day 10-21
⑤	치료 준비·시작	Day 14-30

오늘 물어볼 질문

1. 제 결과는 확진인가요, 아직 의심 단계인가요?
2. 비소세포폐암인가요, 소세포폐암인가요? 세부 조직형은요?
3. 치료를 정하기 전에 어떤 검사 결과가 더 필요한가요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자 — 바로 연락하거나 응급실로

- **피를 한 손가락 이상 뱉거나 객혈이 반복될 때**(컵 단위로 많으면 즉시 119), 갑자기 심해진 숨참·흉통
- **얼굴·목·팔이 붓고 목 혈관이 튀어나옴**(상대정맥 증후군)
- **등 통증 + 다리 힘 빠짐·감각 저하·소변을 못 봄**(척수 압박)
- **갑작스러운 혼동·심한 졸림·헛소리** — 보호자가 보기에 평소와 다름(고칼슘혈증·저나트륨혈증·뇌 전이 가능성)
- 심한 두통·구토·경련·한쪽 마비
- 항암 중 **38°C 이상 발열** — 해열제보다 먼저 연락
- 방사선·면역치료 뒤(몇 주~몇 달 후에도) **새 기침·숨참·발열**
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 많은 객혈·급성 호흡곤란은 즉시 응급 평가가 필요합니다.
2. 얼굴·목 부종은 큰 정맥이 눌린 신호일 수 있습니다.
3. 등 통증과 신경 증상은 척추 전이에 의한 압박일 수 있어 시간이 중요합니다.
4. 혼동·졸림은 혈중 칼슘·나트륨 이상이나 뇌 전이일 수 있습니다.
5. 항암 중 발열은 감염 가능성이 있습니다.
6. 치료 후 새 기침·숨참은 방사선 폐렴·면역치료 폐렴일 수 있습니다.

첫 치료 전에: 진료실·야간 연락처·응급실을 저장하세요(워크북 W1).

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 조직검사 결과와 예정 검사 확인 ② 폐암 진료팀 (호흡기내과·흉부외과·종양내과) 예약 ③ 흡연 중이면 금연 지원 요청.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ 조직검사 결과·조직형 확인(아직이면 결과 예정일 확인)
- ☐ 폐암 다학제 진료가 가능한 진료팀 예약
- ☐ 흡연 중이면 금연 지원 요청(☎ 1544-9030, 보건소 금연클리닉) — 수술 합병증과 치료 효과에 영향

이번 주 할 일

- ☐ PET/CT, 뇌 MRI 일정 ☐ 폐기능 검사(수술·방사선 대상) ☐ 필요 시 EBUS(기관지 내시경 초음파) 일정
- ☐ 유전자검사(NGS)·PD-L1 의뢰 여부와 결과 예정일 확인
- ☐ 산정특례 신청(확진일로부터 30일 이내 신청 시 확진일부터 적용)
- ☐ 2차 소견 예정이면 슬라이드·블록, 영상 CD(DICOM) 준비
- ☐ 복용 약·한약·건강기능식품 목록 정리 — 새로 시작하거나 항응고제를 스스로 끊지 말고 의료진과 상의

보호자 몫

- ☐ 진료 기록 ☐ 숨참·혼동 같은 변화 관찰 ☐ 흡연 이야기로 환자를 탓하지 않기

오늘 물어볼 질문

1. 제 조직검사 결과와 남은 검사 일정은 어떻게 되나요?
2. 유전자검사와 PD-L1 검사는 의뢰됐나요? 결과는 언제 나오나요?
3. 치료 시작까지 대략 얼마나 걸리나요?

4장. 병기와 검사

30초 요약: 병기는 종양 크기(T)·림프절(N)·전이(M)로 정합니다. **PET/CT**는 몸 전체를, **뇌 MRI**는 뇌 전이를, **EBUS·종격동경**은 가슴 안 림프절을 조직으로 확인합니다.

검사	목적	기억할 점
흉부 CT	종양·림프절	기본
PET/CT	림프절·원격전이	염증·결핵도 밝게 보일 수 있어 조직 확인이 필요할 수 있음
뇌 MRI	뇌 전이(2기 이상·증상 시 등)	가능하면 조영 MRI
EBUS·종격동경	종격동 림프절 조직 확인	PET에 이상이 없어도 종양 위치·크기에 따라 시행
EBUS·종격동경	종격동 림프절 조직 확인	PET에 이상이 없어도 종양 위치·크기에 따라 시행. EBUS는 대개 전신마취 없이(진정 상태로), 종격동경은 전신마취로 함
폐기능·운동 검사	수술·방사선을 견딜 수 있는지	수술 범위 결정

병기	쉬운 뜻	흔한 치료 축
1기	작은 종양, 림프절 없음	수술(또는 정위체부방사선 SBRT)
2기	더 크거나 가까운 림프절	수술 ± 수술 전후 약물치료

병기	쉬운 뜻	흔한 치료 축
3기	종격동 림프절 등 국소진행	수술 가능하면 수술 + 약물 / 불가하면 항암방사선 → 공고요법
4기	원격전이(반대쪽 폐·흉막·뼈·뇌·간 등)	유전자·PD-L1에 따른 전신치료 ± 국소치료

- 작은 결절은 위치에 따라 수술 전 조직검사 없이 **수술로 떼어 진단과 치료를 함께** 하는 경우도 있습니다. 이유를 물어보세요.
- 기관지 내시경으로 닿기 어려운 결절은 CT를 보면서 가슴 피부로 가는 바늘을 넣어 조직을 얻기도 합니다(경피적 폐 조직검사). 대개 금식이 필요하고 기흉(폐 밖으로 공기가 새는 것)이나 출혈이 생길 수 있습니다. 혈액을 묽게 하는 약은 미리 알리고, 검사 뒤 숨참·흉통이 생기면 바로 연락하세요.

판독지 단어장

표현	쉬운 말
GGO(간유리음영) / part-solid	뿌옇게 보이는 결절 / 일부 단단한 부분이 섞인 결절
SUVmax	PET 당 섭취 정도. 높으면 활동성 가능성, 염증도 높을 수 있음
mediastinal lymphadenopathy	종격동 림프절이 커 보임 — 전이 확정 아님
pleural effusion	흉막삼출(흉수). 암세포 여부는 검사로 확인

수술 범위

수술	내용	생각할 점
폐엽절제	폐엽 하나	표준적 범위

수술	내용	생각할 점
구역절제	폐엽보다 작은 해부학적 단위	작은 말초 종양에서 선택
썰기절제	결절 주위만	폐기능이 낮을 때 등
전폐절제	한쪽 폐 전체	드물게

검사 체크: 흉부 CT □ · PET/CT □ · 뇌 MRI □ · EBUS/종격동경 □ · 폐기능 □

5장. 유전자(드라이버 변이)와 PD-L1

30초 요약

- 비소세포폐암(특히 선암)은 **EGFR·ALK·ROS1·KRAS G12C·BRAF V600E·MET·RET·HER2·NTRK** 등을 넓게 검사합니다(NGS).
편평상피암도 흡연력·검체에 따라 검사할 수 있습니다.
- **수술을 앞둔 경우에도** EGFR·ALK·PD-L1 결과가 수술 전후 약 선택을 바꿉니다.
- **결과 대기 원칙:** 전이성에서는 유전자 결과가 나오기 전에 면역치료를 서둘러 시작하지 않는 것이 일반적입니다. 증상이 급하면 기다리는 동안의 계획을 상의하세요.

검사	의미	치료 범주(국내 허가·급여 확인 필요)
EGFR(엑손19 결손, L858R 등)	비흡연·동아시아 선암에서 흔함(국내 비소세포폐암의 약 30% 안팎)	먹는 표적치료제 단독 또는 병용
EGFR(엑손19 결손, L858R 등)	비흡연·동아시아 선암에서 흔함(국내 비소세포폐암의 약 30% 안팎)	먹는 표적치료제 단독 또는 병용 (국내에서 흔히 듣는 예: 오시머티닙, 국내 개발 약인 레이저티닙)

검사	의미	치료 범주(국내 허가·급여 확인 필요)
ALK·ROS1 융합	젊은 비흡연자에서 비교적 흔함	먹는 표적치료제
KRAS G12C, BRAF V600E, MET, RET, HER2, NTRK	드문 변이	각각에 맞는 표적치료 범주
PD-L1(TPS)	면역치료 반응 가능성 지표	1% 미만 / 1~49% / 50% 이상으로 나눠 해석

- 결과는 검사 종류에 따라 **수일~수주** 걸립니다.
- 조직이 부족하면 **혈액(액체생검)**으로 보완하기도 합니다.
- 변이 이름 뒤의 세부 표기(예: 엑손19, G12C)까지 그대로 적어 두세요.

결과 대기 중 계획 체크리스트

- ☐ 결과 예정일: _ ☐ **결과 설명 진료 날짜:** _
- ☐ 기다리는 동안 증상(통증·숨참·기침) 조절 계획
- ☐ 증상이 악화되면 연락할 곳
- ☐ 내성이 생기면 다시 조직검사·액체생검이 필요할 수 있다는 점 이해

바이오마커 카드(요약)

- **EGFR 양성:** 대개 먹는 약으로 외래에서 시작. 피부 발진·손발톱 주위염·설사를 미리 관리. 진행 시 재생검으로 내성 원인 확인.
- **ALK 양성:** 먹는 약으로 오랜 기간 조절하는 경우가 많음. 뇌 전이에도 효과가 있는 약이 있음.
- **PD-L1 50% 이상:** 면역치료 단독 또는 항암 병용 범주. 드라이버 변이가 있으면 일반적으로 표적치료가 우선.

결과 기록

EGF R	AL K	ROS 1	KRA S	BRA F	ME T	RE T	HER 2	NTR K	PD-L1 TPS
----------	---------	----------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	--------------

%

오늘 물어볼 질문

- 어떤 유전자 검사를 했고 결과는 언제 나오나요?
- 제 결과로 표적치료·면역치료 중 무엇이 해당되나요?
- 결과를 기다리는 동안 증상은 어떻게 관리하나요?

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

6장. 치료 경로 지도(비소세포폐암)

30초 요약: 수술 가능한 비소세포폐암은 **수술 + (종양 크기·림프절·유전자에 따라) 수술 전·후 또는 전후 약물치료**가 표준 범주입니다. 절제 불가 3기는 **항암방사선 → 공고요법**, 4기는 **유전자·PD-L1 기반 전신치료**입니다.

상황	치료 범주(국내 허가·급여 확인 필요)
1기, 작은 종양	수술 후 경과관찰이 많음. 수술이 어려우면 SBRT
2~3기 일부 수술 가능(종양 약 4cm 이상 또는 림프절 양성)	수술 전 항암 + 면역치료 , 또는 수술 전후(주변수술기) 면역치료, 또는 수술 후 항암 ± 면역치료. 면역치료 전 EGFR·ALK 확인
EGFR 양성 수술 후	표적 보조요법 (면역치료 대신)
ALK 양성 수술 후	표적 보조요법
3기 절제 불가	동시 항암방사선 → 면역 공고요법 (약 1년), EGFR 양성은 표적 공고요법
4기 드라이버 변이 있음	해당 표적치료(단독 또는 병용)
4기 드라이버 변이 없음	면역치료 단독(PD-L1 높음) 또는 항암 + 면역치료
4기 국소 증상	통증·뇌 전이·출혈 등에 방사선 병행

국내 진료 기록이나 설명에서는 4기 전신치료를 '고식적 항암' 또는 '완화적 항암'이라고 부르기도 합니다. 치료를 포기한다는 뜻이 아니라, 암을 조절하며 오래·편하게 지내는 것이 목표라는 뜻입니다.

내 수술 전후 치료 정리 시트

항목	내 결과	의미
임상 병기		수술 전 약물치료 대상 여부
EGFR / ALK		양성이면 면역치료 대신 표적 보조요법 범주
PD-L1		면역치료 결정에 참고
폐기능		수술 범위
다학제 의견		

시나리오(가상)

- 63세, 1기 선암 2cm, EGFR 음성 → 폐엽 또는 구역절제 → 병리 결과에 따라 경과관찰.
- 58세, 3A기, EGFR 음성·PD-L1 30% → 수술 전 항암 + 면역치료 3~4주기 → 수술 → 병리 반응에 따라 면역치료 지속 여부.
- 66세, 2기, EGFR 엑손19 결손 → 수술 → 보조항암 여부 → 표적 보조요법.

오늘 물어볼 질문

1. 제 병기에서 수술이 가능한가요? 수술 전후 약물치료가 필요한가요?
2. EGFR·ALK 결과가 제 치료 순서를 바꾸나요?
3. 다학제 진료에서 상의했나요?

7장. 수술

30초 요약: 대부분 흉강경·로봇으로 수술하며, 폐엽절제가 표준 범위입니다.
수술 전 **금연과 호흡 운동**이 회복을 돕습니다.

수술 전 2주

- 금연(가능한 한 빨리) □ 하루 20~30분 걷기, 계단 오르기 □ 폐활량계·심호흡 연습 □ 복용 약 정리(항응고제 등) □ 간병·휴직 계획

회복 달력(일반적 예시)

시기	몸	할 일
1-3일	홍관, 통증	진통제 충분히, 기침·가래 배출, 걷기
4-7일	홍관 제거·퇴원	상처 관리, 폐활량계
2-6주	숨참·피로 점차 회복	운전·복직 시점 상의, 무거운 물건 피하기
병리 결과	—	수술 후 치료 결정(pTNM·절제면·림프절 수)

수술 후 퇴원했다면: 38℃ 이상 발열, 숨참 악화, 상처 고름, 피 섞인 가래 증가는 연락합니다.

8장. 방사선치료

30초 요약: 방사선은 ① 수술 대신 근치(SBRT, 보통 3~8회) ② 3기 항암방사선(약 6주) ③ 증상 완화(통증·뇌 전이 등) 세 역할을 합니다.

- 흔한 부작용: 피로, 식도염(삼킬 때 통증), 피부 자극, 기침.
- **방사선 폐렴**은 치료가 끝나고 몇 주~몇 달 뒤 생길 수 있습니다. 새 기침·숨참·발열을 알려세요.
- **삼킬 때 통증으로 물·음식을 못 삼키면** 연락합니다.

9장. 전신치료: 항암·표적·면역

범주	대표 부작용	바로 연락
항암화학요법	메스꺼움, 백혈구 감소, 피로	38°C 이상 발열
표적치료(먹는 약)	발진, 손발톱 주위염, 설사, 간수치, 드물게 폐렴	새 숨참·기침
면역치료	피부·갑상선·장·간·폐·심장 등 면역 부작용 (몇 달 뒤에도)	심한 설사, 숨참, 흉통, 심한 피로

먹는 표적치료제 생활 가이드

- 같은 시간에 복용, 빠뜨렸을 때 대처를 약사에게 확인.
- 발진: 순한 보습, 자외선 차단, 처방 연고. 손발톱: 꼭 끼는 신발 피하기.
- 설사: 수분 보충, 처방 지사제. 하루 4~6회 이상이면 연락.
- 다른 약·한약·건강기능식품과의 상호작용 확인.

면역치료 카드(지갑용)

"면역항암제 치료 중입니다. 약 이름: _ / **마지막 투여일:** _ / 연락처: _____" —
응급실에 가면 먼저 보여 주세요.

10장. 소세포폐암 지도

30초 요약

- **제한기**(한쪽 가슴과 주변 림프절): 항암 + 흉부 방사선(가능하면 동시) → **면역 공고요법** 범주. 아주 작은 경우 수술도 가능.
- **확장기**: **항암 + 면역치료** → 면역 유지. 진행 시 **이중특이항체** 등 새 치료 범주(국내 허가·급여 확인 필요).
- 뇌 전이 예방: **예방적 뇌 방사선(PCI)** 또는 정기 뇌 MRI 추적 — 장단점(기억력 영향 등)을 상의합니다.
- 소세포폐암은 바이오마커 검사가 일반적으로 1차 치료를 바꾸지 않습니다.

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

치료 목표를 묻는 질문

1. 이 치료의 목표는 무엇인가요? (암 크기 줄이기 / 진행 늦추기 / 증상 줄이기)
2. 치료 효과는 언제, 어떤 검사로 확인하나요?
3. 이 치료를 받지 않거나 쉬면 어떤 일이 예상되나요?

완화의료 이용하기

- 대부분의 암 병원에 **완화의료팀(자문형)**이 있습니다. 통증, 숨참, 메스꺼움, 불면, 불안 조절을 담당 교수에게 요청하면 연결됩니다.
- 호스피스·완화의료는 입원형·가정형·자문형으로 나뉘며, 지정 기관과 이용 조건은 국립암센터 중앙호스피스센터 누리집이나 병원 사회사업팀에서 확인합니다.
- 완화의료를 받는다고 해서 항암치료를 포기하는 것이 아닙니다.

미리 생각해 둘 것(원할 때만)

- **사전연명의료의향서**: 19세 이상이면 건강할 때도 작성할 수 있습니다. 보건소·지정 등록기관에서 작성하며, 언제든지 변경·철회할 수 있습니다 (국립연명의료관리기관).
- 치료를 잠시 쉬거나 멈추는 선택도 존중되는 결정입니다. 결정은 한 번에 하지 않아도 됩니다.
- 내가 직접 말하기 어려워질 때 나 대신 의견을 전할 사람을 정해 가족에게 알려 둡니다.

2차 소견과 병원 선택

30초 요약

- 2차 소견은 담당 의사를 의심하는 일이 아니라 **큰 결정을 확인하는 일**입니다. 대부분의 의사는 자연스럽게 받아들입니다.
- 2차 소견 때문에 치료를 몇 주씩 미루지 않도록 **일정을 먼저 정하고** 움직입니다.
- 가장 중요한 준비물은 병리 슬라이드·블록과 영상 CD입니다.

2차 소견이 특히 도움이 되는 경우

- 병리 결과가 드문 조직형이거나, 병원마다 해석이 갈릴 수 있다고 들었을 때
- 수술과 비수술 치료 중 선택지가 둘 이상일 때
- 기능 보존 수술이나 드문 치료처럼 경험 많은 센터가 중요한 치료일 때
- 설명을 들었는데도 결정이 서지 않을 때

병원을 고를 때 물어볼 것

1. 이 병원에서 폐암 환자를 **다학제(여러 과가 함께 보는) 진료**로 상의하나요?
2. 제게 필요한 치료(수술·방사선·항암·임상시험 등)를 **한 병원**에서 받을 수 있나요?
아니면 연계 병원이 정해져 있나요?
3. 치료 중 밤이나 휴일에 문제가 생기면 **어디로 연락**하나요?
4. 첫 치료까지 대략 몇 주가 걸리나요?

집과의 거리도 중요한 기준입니다. 매일 가야 하는 방사선치료나 잦은 외래가 예정되어 있다면, 통원 부담과 응급 시 이동 시간을 함께 따져 보세요.

2차 소견 준비 체크리스트

- ☐ 진료의뢰서(상급종합병원은 필수)
- ☐ 병리보고서 + 슬라이드/블록 대여
- ☐ 영상 CD + 판독지
- ☐ 혈액검사 결과, 복용 약 목록
- ☐ 내가 가장 궁금한 질문 3개(워크북 「질문지」)

최신 치료와 임상시험

- 임상시험은 "마지막에 기대는 실험"만이 아닙니다. 진단 초기부터 **표준치료와 함께 고려할 수 있는 선택지**입니다.

- 임상시험에 참여해도 언제든지 그만둘 수 있고, 위약(가짜약)만 단독으로 쓰는 암 임상시험은 드뭅니다. 위약이 포함되면 사전에 설명을 듣습니다.
- 연구 약값은 보통 연구 쪽이 부담하지만, 교통비·추가 방문 등 부대 비용은 확인이 필요합니다.

찾는 곳

- 담당 교수에게 "제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?"라고 직접 묻기 — 가장 빠릅니다.
- 한국임상시험포털(KoNECT), 식품의약품안전처 의약품안전나라 임상시험 정보, ClinicalTrials.gov(영문)

물어볼 질문

1. 이 연구는 무엇을 비교하나요? 표준치료를 받지 못하게 되나요?
 2. 방문 횟수와 검사가 얼마나 늘어나나요?
 3. 중간에 그만두면 어떤 치료를 받게 되나요?
-

PART 3. 30일 실행 로드맵

Day 0-3 · 확인하기

- ☐ 조직검사·조직형 ☐ 폐암 진료팀 예약 ☐ 금연 지원 ☐ 연락처 저장 ☐ 산정특례 문의

Day 4-7 · 검사받기

- ☐ PET/CT ☐ 뇌 MRI ☐ 폐기능 ☐ EBUS(해당 시) ☐ NGS·PD-L1 의뢰 확인

Day 8-14 · 결정하기

- ☐ 병기 설명 ☐ 다학제 결과 ☐ 수술/항암방사선/전신치료 경로 ☐ 결과 대기 중 계획 ☐ 필요 시 2차 소견

Day 15-21 · 준비하기

- ☐ 수술: 호흡 운동·간병 ☐ 방사선: 모의치료 ☐ 항암·면역: 채혈·교육·면역치료 카드 ☐ 직장 일정

Day 22-30 · 시작하기

- ☐ 첫 치료 ☐ 증상 일지 ☐ 새 숨참·발열 연락 기준 재확인 ☐ 보험 서류 1차 접수
-

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

숨참·기침·체력

30초 요약: 숨참과 피로는 흔하지만 관리할 수 있습니다. **호흡재활**과 가벼운 걷기는 도움이 됩니다. 갑자기 심해진 숨참은 2장의 응급 신호입니다.

- 입술 오므리기 호흡: 코로 2초 들이쉬고, 입술을 오므려 4초 내쉬기.
- 하루 할 수 있는 만큼 걷기, 앉았다 일어서기. 뼈 전이가 있으면 근육운동 전 상의.
- 기침·가래: 수분 섭취, 처방받은 약. 피 섞인 가래가 늘면 알리기.
- 재활의학과·호흡재활 프로그램을 요청할 수 있습니다.

추적

- 수술·근치 치료 후에는 정기 흉부 CT로 추적합니다(간격은 병기·치료에 따라).
- 4기는 치료 반응 평가 CT를 정해진 간격으로 찍습니다. 면역치료 초기에 종양이 일시적으로 커 보이는 경우(가성진행)도 있어 판단은 의료진이 합니다.
- 금연은 진단 후에도 의미가 있습니다.

치료 중 흔한 증상, 집에서 할 일과 연락 기준

아래는 여러 암 치료에서 공통으로 흔한 증상입니다. **치료 병원의 안내가 항상 우선**이며, "연락" 칸에 해당하면 다음 예약까지 기다리지 마세요.

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
메스꺼움·구토	처방받은 구토 예방약을 시간 맞춰 (증상이 생긴 뒤가 아니라 미리). 조금씩 자주, 차갑고 냄새가 약한 음식, 생강차·크래커	하루 3회 이상 구토, 물도 못 마심, 24시간 소변이 거의 없음
피로	짧은 낮잠(30분 이내), 가벼운 걷기, 우선순위 정해 에너지 아끼기, 도움 요청	숨참·어지럼·심한 창백(빈혈 가능), 일상생활이 불가능
입안 혈음	부드러운 칫솔, 무알코올 가글(소금·베이킹소다 물), 자극적·뜨거운 음식 피하기	통증으로 먹거나 마시지 못함, 흰 반점·출혈, 발열 동반
변비	수분, 걷기, 처방 변비약. 진통제(마약성) 복용 중이면 변비약을 미리 함께	3일 이상 변이 없고 복통·구토, 배가 부풀
설사	수분·전해질(이온음료 희석, 미음), 기름진 음식·유제품·카페인 줄이기, 처방 지사제	하루 4~6회 이상, 밤에도 계속, 혈변, 어지럼·소변 감소, 면역치료 중 설사
불면	일정한 기상 시간, 낮잠 제한, 잠자리에서 휴대폰 멀리, 스테로이드는 아침 복용(지시대로)	2주 이상 계속, 불안·우울 동반
탈모	순한 샴푸, 짧은 머리, 모자·두건·가발, 두피 자외선 차단	— (대개 치료 후 다시 자람)
피부 발진·건조	순한 보습제 하루 2회 이상, 미지근한 물, 자외선 차단	물집·벗겨짐, 넓게 번짐, 점막(입·눈) 침범
손발 저림	찬 것 피하기(일부 약), 따뜻한 양말·장갑, 낙상 주의	단추·젓가락·걸기가 어려워짐 — 다음 투여 전에 꼭 알리기

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
식욕 저하· 체중 감소	먹을 수 있을 때 먹기, 고단백 간식, 영양 보충 음료	한 달 5% 이상 체중 감소, 평소의 절반 이하로 1주 이상

열이 나면: 항암 중 38°C 이상(병원 기준에 따라 37.8°C 이상 1시간 지속 등)은 **해열제를 먹기 전에 먼저 연락**하는 것이 원칙입니다. 열을 내리면 감염 신호를 놓칠 수 있습니다.

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

내 마음 온도계(고통 선별)

지난 1주일 동안 내 마음의 고통은 몇 점이었나요? (0 = 전혀 없음, 10 = 극심함)

날짜 점수(0~10) 가장 힘든 것(☐ 걱정 ☐ 잠 ☐ 통증 ☐ 돈 ☐ 가족 ☐ 일 ☐ 기타)

- **4점 이상**이 계속되면 다음 진료 때 점수를 그대로 말하세요. 대부분의 암 병원에는 정신건강의학과·임상심리·사회사업팀 연결 경로가 있습니다.
- 불면이 1~2주 이상 계속되면 수면 치료를 받을 수 있습니다. 잠은 치료를 건디는 체력입니다.
- 병원 밖 도움: 전국 지역암센터의 **암생존자통합지지센터**(☎ 1577-9740)에서 상담·심리지지·자기관리 프로그램을 운영합니다. 암 정보가 궁금하면 국가암지식정보센터 상담(☎ 1577-8899, 평일 9~18시)을 이용할 수 있습니다.

불안이 몰려올 때 5분 방법

1. **숨:** 4초 들이쉬고, 6초 내쉬기를 5번.
2. **이름 붙이기:** "지금 나는 ○○ 결과가 걱정된다"라고 소리 내거나 적기.
3. **내 몫 나누기:** 지금 내가 할 수 있는 일 1개(전화 1통, 서류 1장)와 의료진 몫을 나눠 적기.
4. **정보 시간 정하기:** 인터넷 검색은 하루 30분, 정해 둔 시간에만. 밤 검색은 불안을 키웁니다.

"내 탓일까?"라는 생각

암은 한 가지 원인으로 생기지 않습니다. 생활습관, 감염, 유전, 나이, 그리고 설명되지 않는 우연이 겹칩니다. **원인 찾기보다 지금부터의 계획**에 에너지를 쓰는 편이 나를 돕습니다. 가족이나 주변 사람이 원인을 따져 묻는다면 "지금은 치료 계획에 집중하고 싶어"라고 말해도 됩니다.

희망과 현실을 함께 들고 가기

통계(생존율)는 많은 사람의 평균이지 나 한 사람의 예언이 아닙니다. 궁금하다면 담당 의사에게 "제 병기와 상태에서 치료 목표가 무엇인가요?"라고 물어보세요. 들고 싶지 않은 정보는 "지금은 듣지 않겠다"고 말할 권리도 있습니다.

보호자에게

보호자가 첫 30일에 할 수 있는 가장 좋은 일

- **기록 담당:** 진료실에서 답을 적습니다. 환자는 듣는 데 집중할 수 있습니다.
- **일정 담당:** 검사·진료·서류 일정을 한 곳(달력·앱)에 모읍니다.
- **연락 창구:** 친척·지인에게 소식을 전하는 사람을 한 명으로 정하면 환자가 같은 이야기를 반복하지 않아도 됩니다.
- **결정은 환자:** 의견은 말하되, 치료 결정의 주인은 환자입니다.

피하면 좋은 말과 바꿔 쓸 말

피하면 좋은 말	바꿔 쓸 말
"긍정적으로 생각해야 나아"	"힘든 마음 그대로 말해도 돼"
"왜 검진을 안 받았어"	"지금부터 같이 챙기자"
"○○ 먹으면 낫는데"	"새로 먹고 싶은 게 있으면 의사 선생님께 같이 물어보자"
"너보다 더 힘든 사람도 있어"	"네가 힘든 건 힘든 거야"

아이에게 알릴 때

- 아이의 나이에 맞게, **짧고 사실대로:** "(엄마·아빠·할머니 등 아이가 부르는 호칭)가 몸에 아픈 혹이 생겨서 병원에서 치료를 받을 거야."
- 아이가 자주 하는 걱정 세 가지에 먼저 답합니다: **네 탓이 아니야 / 옳은 병이 아니야 / 누가 너를 돌봐줄지 정해져 있어.**
- 학교 담임에게 알릴지, 누가 알릴지 미리 정합니다.

보호자의 휴가 제도

일하는 보호자는 **가족돌봄휴직**(연간 최대 90일)과 그 안에서 하루 단위로 쓰는 **가족돌봄휴가**(연간 최대 10일)를 회사에 신청할 수 있습니다(남녀고용평등법,

2026.10 기준·고용노동부 확인). 진료 동행이 잦은 첫 30일에 특히 유용합니다.

보호자 자신을 위해

보호자의 소진은 흔합니다. 하루 30분은 나를 위한 시간을 지키세요. 병원
사회사업팀과 환우·보호자 모임은 보호자도 이용할 수 있습니다.

직장과 일상

- **언제·누구에게·얼마나** 말할지는 내가 정합니다. 직속 상사와 인사 담당자에게 "치료 일정 때문에 근무 조정이 필요하다" 정도만 알려도 충분한 경우가 많습니다.
- 치료 일정이 나오면 **근무 조정안**(단축근무, 재택, 연차·병가 조합)을 내가 먼저 제안하면 협의가 쉬워집니다.
- 피로는 치료 중 가장 흔한 증상입니다. 치료 직후 며칠은 일을 줄이는 계획을 미리 세웁니다.
- 자영업자라면 매출보다 **현금 흐름 3개월**을 먼저 계산하고, 사회사업팀에 지원제도를 문의합니다.
- 복귀는 한 번에 100%가 아니라 단계적으로. 복귀 시점은 담당 의사와 상의합니다.
- 암생존자통합지지센터(☎ 1577-9740)에는 직장·학교 복귀를 돕는 프로그램이 있습니다(지역별 운영 확인).

먹는 것과 움직이는 것

식사 원칙

- 치료 중 목표는 "특별한 음식"이 아니라 **체중과 근육 유지**입니다. 고른 식사와 충분한 단백질(생선·달걀·두부·살코기·유제품)을 챙깁니다.

- 암 치료에 특별히 좋은 음식이나 꼭 피해야 할 "나쁜 음식"이 따로 정해져 있지는 않습니다. "좋다는 음식"만 먹거나 여러 음식을 가리면 오히려 영양이 치우치고 체력이 떨어져 치료를 버티기 어려워집니다.
- 입안이 험했을 때는 잡곡밥보다 부드러운 흰쌀밥이 나올 수 있고, 체중이 줄고 있다면 기름을 지나치게 제한할 필요도 없습니다. 유기농 식품이 치료에 특별히 도움이 된다는 근거는 뚜렷하지 않습니다.
- 체중이 한 달에 5% 이상 줄거나 먹는 양이 평소의 절반 이하로 1주 이상 이어지면 영양 상담을 요청합니다.
- 항암치료 중 면역이 떨어질 때는 날음식·덜 익힌 고기·살균 안 된 유제품을 피하라는 안내를 받을 수 있습니다. 병원 안내를 따르세요.
- **건강기능식품·한약·즙·고용량 비타민**은 항암제나 수술·방사선과 상호작용하거나 간·신장에 부담을 줄 수 있습니다. 시작 전에 꼭 의료진과 약사에게 보여 주세요.

움직이기

- 걷기처럼 가벼운 활동은 피로와 기분을 개선하는 근거가 있습니다. 컨디션에 맞춰 하루 10분부터 시작합니다.
- 일반적인 건강 목표는 주 150분 중간 강도 활동이지만, 치료 중에는 **할 수 있는 만큼**이 기준입니다.
- 발열, 심한 빈혈·어지럼, 뼈 전이 통증, 수술 직후에는 운동 강도를 의료진과 상의합니다.
- 담배는 상처 회복과 치료 효과, 다른 암 위험에 모두 영향을 줍니다. 금연 클리닉(보건소)과 금연상담전화 ☎ 1544-9030을 이용하세요.

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

- 1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
- 2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
- 3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

1. 산정특례(중증질환 본인부담 경감)

항목	내용(2026.10 기준, 확인 필요)
대상	암으로 확진된 환자(폐암 포함). 상피내암(0기)·경계성 종양 등은 대상·비율이 다를 수 있어 원무과 확인
혜택	건강보험 급여 진료비의 본인부담 약 5%(입원·외래). 비급여·선별급여는 해당하지 않거나 비율이 다름
기간	적용 시작일(확진일 또는 신청일)부터 5년. 5년 뒤 남아 있는 암·재발·전이가 있으면 재등록 심사
신청 시한	확진일로부터 30일 이내 신청하면 확진일부터 적용. 그 뒤에 신청하면 신청일부터 적용
방법	진단한 의사가 산정특례 등록 신청서를 작성 → 대부분 병원 원무과가 공단에 전송. 직접 제출도 가능

확인할 것

- ☐ 병원이 대신 접수했는지, 등록 결과(문자·공단 앱)를 받았는지
- ☐ 다른 병원으로 옮겨도 산정특례는 유지됩니다. 새 병원 원무과에 등록 사실만 알리면 됩니다.
- ☐ 확진 전 검사비는 적용 시점에 따라 경감되지 않을 수 있습니다.

2. 의료비 부담을 덜어주는 제도

제도	핵심	문의
본인부담상한제	1년간 낸 건강보험 본인부담금이 소득 구간별 상한을 넘으면 남은 금액을 돌려받음(비급여 제외)	국민건강보험공단 1577-1000
재난적 의료비 지원	소득·재산 기준을 충족하고 의료비 부담이 큰 경우 일부 지원(비급여 일부 포함)	공단 지사·병원 사회사업팀
국가 암환자 의료비 지원	의료급여 수급자·차상위 등 해당자 대상 지원	주소지 보건소
병원 사회사업팀 (의료사회복지사)	후원 연계, 간병·교통·숙소 정보, 제도 신청 도움	진료 병원 사회사업팀

대상 기준과 금액은 해마다 바뀝니다. "내가 해당되는지"는 병원 사회사업팀에 한 번에 물어보는 것이 가장 빠릅니다.

3. 보험 청구 서류 체크리스트

민간 암보험(진단비)

- ☐ 진단서(질병분류코드 포함) — 보험사 양식이 있는지 먼저 확인
- ☐ 조직병리검사 결과지(병리보고서) — 대부분의 약관이 병리 확정을 요구합니다

- □ 약관에서 "**유사암·소액암**"(갑상선암, 제자리암/상피내암, 경계성 종양, 기타 피부암 등) 분류를 확인 — 진단비가 다를 수 있습니다
- □ 청구 기한(보험금 청구권 소멸시효는 3년)

실손의료보험

- □ 진료비 영수증 + 진료비 세부산정내역서(비급여 항목 확인용)
- □ 일정 금액 이상은 진단서·입퇴원확인서 추가
- □ 가입 시기에 따라 보장 범위(비급여 주사·도수 등)가 다릅니다

보험 상담에서 "진단서는 몇 통이 필요한가요?"를 먼저 물어보고, 병원에서는 한 번에 필요한 부수만큼 발급받으면 비용과 시간을 아낄 수 있습니다.

4. 회사·학교에 낼 서류

- □ 진단서 또는 소견서(치료 예정 기간 포함 여부 확인)
- □ 회사 취업규칙의 **병가·질병휴직** 조항 확인 — 법정 의무 병가는 없고 회사 규정에 따름(공무원·교원은 별도 규정)
- □ 상병수당: 일부 지역 시범사업 중 — 거주 지역·자격을 공단에 확인
- □ 개인 의료정보는 **필요한 만큼만** 알립니다. 병명 공개 범위는 내가 정합니다 (PART 4 「직장과 일상」 참고).

5. 진료 서류 모아두기(2차 소견·전원 대비)

서류	어디서	메모
병리보고서(조직검사 결과지)	진단 병원 의무기록팀	바이오마커 결과 포함 여부
병리 슬라이드·파라핀 블록 대여	진단 병원 병리과	다른 병원 재판독·추가검사에 필요. 반납 기한 확인

서류	어디서	메모
영상 CD + 판독지	진단 병원 영상의학과· 의무기록팀	CT·MRI·PET 모두
혈액검사 결과	의무기록팀	최근 것
진료의뢰서(소견서)	담당 의사	상급종합병원 외래는 의뢰서가 있어야 건강보험 적용

폐암 참고: 질병코드는 C34 계열입니다. 영상 CD는 DICOM 원본으로 받아야 다른 병원에서 판독할 수 있습니다. 유전자검사를 다른 병원에서 추가로 할 수 있으니 블록 대여 가능 여부도 확인하세요.

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 3개만 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다.

- 1. 확진인가요? 비소세포인가요, 소세포인가요?
- 2. 제 병기는 무엇이고, 뇌 MRI·EBUS가 필요한가요?
- 3. 유전자검사(NGS)와 PD-L1 결과는 무엇인가요?
- 4. 수술이 가능한가요? 수술 전후 약물치료가 필요한가요?
- 5. EGFR·ALK 결과가 치료 순서를 바꾸나요?
- 6. 수술이 어렵다면 방사선(SBRT·항암방사선)은 어떤가요?
- 7. 4기라면 치료 목표와 1차 치료는 무엇인가요?
- 8. 치료 중 바로 연락해야 할 증상은 무엇인가요?
- 9. 제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?
- 10. 금연·호흡재활·심리 지원은 어디서 받나요?

내 폐암 한 장 요약

항목	내 기록
조직형	선암 / 편평상피 / 소세포 / 기타 _____
병기	임상 _ → 병리 _ (✓/⌚)
림프절	종격동 _ (확인 방법 _)
뇌 MRI	_____
드라이버 변이	EGFR _ ALK _ 기타 _____

항목	내 기록
PD-L1 TPS	_____%
첫 치료	수술 / SBRT / 항암방사선 / 표적 / 면역 ± 항암
금연	해당 없음 / 진행 중 / 완료
산정특례	☐ 신청 ☐ 완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① 제 조직형과 병기는? ② 유전자·PD-L1 결과는 언제, 무엇인가요? ③ 첫 치료는 무엇이고 언제 시작하나요?

같은 진단, 다른 30일 (가상 사례)

감수단 환자 페르소나를 바탕으로 재구성한 가상의 이야기입니다.

63세 상철 씨 — 1기 선암, 수술 예정, 전 흡연자 "담배 때문"이라는 자책이 컸다. 담당의는 "지금은 수술 준비에 집중하자"며 수술 전 2주 동안 걷기와 호흡 연습을 권했다. EGFR 결과가 나온 뒤에야 수술 후 치료 계획이 완성됐다. "결과가 다 나올 때까지 기다리는 게 왜 중요한지 알게 됐어요."

45세 은정 씨 — 비흡연, EGFR 4기, 두 아이 엄마 "왜 나지"라는 질문에 답은 없었다. 대신 먹는 표적치료제를 외래에서 시작했고, 발진 관리법을 미리 배웠다. 아이들에게는 "엄마가 아픈 혹은 약으로 줄이는 중"이라고 말했다. "원인을 찾는 데 쓰던 힘을 아이들과의 저녁에 쓰기로 했어요."

76세 기현 씨 — 소세포폐암 확장기, 아들과 동행 "글씨 크게, 오늘 할 일만"이 그의 요청이었다. 아들은 한 장 요약과 면역치료 카드를 만들었다. 항암 + 면역치료를 시작하면서 완화의료팀이 숨참과 잠을 함께 봤다. "치료 목표를 먼저 들으니, 남은 시간을 어떻게 쓸지 생각할 수 있었습니다."

용어사전

용어	쉬운 뜻
비소세포폐암 / 소세포폐암	폐암의 두 큰 갈래. 치료가 다름
드라이버 변이	암을 자라게 하는 핵심 유전자 변화(EGFR·ALK 등)
NGS	여러 유전자를 한 번에 보는 검사
액체생검	혈액으로 하는 유전자 검사
PD-L1(TPS)	면역치료 반응 가능성 지표
EBUS	기관지 내시경 초음파로 림프절 조직을 얻는 검사
SBRT(정위체부방사선)	몇 번에 걸쳐 높은 선량을 정밀하게 주는 방사선
주변수술기 치료	수술 전과 후에 함께 하는 약물치료
공고요법	항암방사선 뒤 효과를 굳히는 치료
가성진행	면역치료 초기에 종양이 일시적으로 커 보이는 현상
PCI(예방적 뇌 방사선)	소세포폐암에서 뇌 전이를 예방하는 방사선
이중특이항체	두 표적에 동시에 붙는 항체 약

자주 묻는 질문 12

Q1. 조직검사가 암을 퍼뜨리지 않나요? 조직검사로 암이 퍼지는 일은 매우 드물고, 정확한 진단과 유전자검사를 위해 필요합니다.

Q2. 유전자 결과를 기다리는 동안 치료가 늦어져도 괜찮나요? 전이성 비소세포폐암에서 결과를 기다리는 몇 주는 맞는 약을 고르기 위한 시간입니다. 증상이 심하면 기다리는 동안의 계획을 상의하세요.

Q3. 표적치료제는 평생 먹나요? 효과가 있고 부작용이 견딜 만하면 계속 먹는 경우가 많습니다. 효과가 떨어지면 재생검으로 원인을 찾아 다음 약을 고릅니다. 수술 후 보조요법은 정해진 기간(약 2~3년 범위)이 있습니다.

Q4. 면역치료는 누구에게나 효과가 있나요? 아닙니다. PD-L1 수치·드라이버 변이 여부 등에 따라 다르며, 드라이버 변이가 있으면 대개 표적치료가 우선입니다.

Q5. 수술 후 폐활량이 얼마나 줄어드나요? 수술 범위와 원래 폐기능에 따라 다릅니다. 폐기능 검사 결과로 예측해 주니 "수술 후 일상생활은 어느 정도 가능할까요?"라고 물어보세요.

Q6. 수술 대신 방사선(SBRT)은 어떤가요? 수술이 어렵거나 원하지 않는 초기 환자에게 선택지가 됩니다. 두 방법의 장단점을 양쪽 진료과에서 들어 보세요.

Q7. 지금이라도 담배를 끊으면 의미가 있나요? 네. 수술 합병증, 방사선 부작용, 치료 효과, 다른 암 위험에 모두 영향을 줍니다.

Q8. 기침·가래에 좋은 음식이 있나요? 특정 음식보다 충분한 수분과 처방약이 도움이 됩니다. 피 섞인 가래가 늘면 알리세요.

Q9. 뇌 전이가 있으면 치료가 끝난 건가요? 아닙니다. 방사선(정위방사선수술 등)과 뇌에 잘 들어가는 표적치료제가 있습니다.

Q10. 가족도 폐암 검사를 받아야 하나요? 국가 폐암 검진(저선량 CT)은 현재 54~74세, 30갑년 이상 흡연력이 있는 고위험군이 2년마다 받습니다. 대상 연령·흡연력 기준을 넓히는 방안이 2028년 목표로 검토되고 있습니다(시행 여부 확인). 비흡연 가족은 현재 기준에 해당하지 않을 수 있어, 걱정되면 진료 때 상의하세요.

Q11. 면역치료 후 몇 달 뒤에 생긴 증상도 연관이 있나요? 그럴 수 있습니다. 면역치료 부작용은 치료가 끝난 뒤에도 생길 수 있어, 다른 병원에 가도 면역치료 이력을 알리세요.

Q12. 숨이 차서 걷기가 무섭습니다. 천천히, 입술 오므리기 호흡을 하며 짧게 자주 걷는 것부터 시작하세요. 호흡재활을 요청할 수 있습니다.

진료실 대화법: 15분 진료를 30분처럼

30초 요약: 질문은 3개로 줄여 가져가고, 보호자가 적고, 마지막에 "제가 이해한 것이 맞는지 말해 볼게요"로 확인합니다.

진료 전날

- ☐ 질문 3개를 우선순위로 적기(워크북 W2)
- ☐ 지난 진료 이후 바뀐 증상·약을 한 줄씩
- ☐ 검사 결과지·영상 CD·복용 약 목록 챙기기

진료실에서

1. **첫 문장으로 가장 중요한 것부터:** "오늘 가장 궁금한 건 첫 치료가 무엇이고 언제 시작하는지예요."
2. 어려운 말이 나오면: "그 말을 쉽게 다시 설명해 주시겠어요?" "종이에 적어 주실 수 있나요?"
3. 선택지가 나오면: "선택지마다 장점과 단점, 그리고 선생님이라면 무엇을 고르실지 여쭙봐도 될까요?"
4. 끝나기 전: "제가 이해한 대로 말해 볼게요. ○○하고, 다음은 ○월 ○일 ○○ 검사죠?"
5. 연락처: "집에서 문제가 생기면 누구에게 연락하나요?"

녹음하고 싶다면

진료 내용을 기억하기 위해 녹음하고 싶을 때는 **먼저 의료진에게 양해를 구하세요.**
허락이 어려우면 보호자 기록으로 대신합니다.

다학제 진료

여러 과(수술·종양내과·방사선종양학과·영상의학과·병리과 등)가 한자리에서 치료를 상의하는 진료입니다. 치료 선택지가 여럿이거나 순서가 중요한 경우 "다학제 진료를 받을 수 있나요?"라고 물어보세요.

검사 준비 카드

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
CT(조영)	몇 시간 금식(병원 지시), 물 충분히(제한 없을 때)	조영제 알레르기, 신장 기능 저하, 당뇨약 (메트포르민), 임신 가능성	촬영은 10~20분
MRI	금속 제거, 일부는 금식	심박동기·인공와우·몸속 금속, 폐소공포증(진정 상담), 신장 기능	30~60분
PET/CT	(FDG PET) 4~6시간 금식, 전날 격한 운동 피하기 · 다른 종류의 PET은 병원 안내	당뇨(혈당 조절법 미리 확인), 임신·수유	주사 후 대기 포함 2~3시간
조직검사 (바늘)	금식 여부 확인	혈액을 묽게 하는 약(중단 여부는 의료진 지시), 알레르기	시술 후 관찰 수시간
내시경	금식, 대장은 장 정결제	혈액을 묽게 하는 약, 당뇨약	진정 시 보호자 동행·당일 운전 금지
뼈스캔	주사 후 물 많이 마시기	임신·수유	주사 후 2~4시간 대기

검사 결과는 "검사를 한 날"이 아니라 **"결과 설명을 듣는 날"**을 미리 예약해 두면 기다리는 불안이 줄어듭니다.

워크북

이 장은 오려 쓰거나 복사해 쓰도록 만들었습니다. 진료실에는 이 페이지만 들고 가도 됩니다.

W1. 비상 연락처 카드 (휴대폰 사진으로도 저장)

항목	기록
담당 교수 / 진료과	
평일 진료실·외래 간호사실 ☎	
야간·휴일 연락처 ☎	
가까운 응급실(치료 병원 우선)	
항암·방사선 치료실 ☎	
보호자 1 / 보호자 2 ☎	
국가암지식정보센터 암정보 상담(평일 9~18시)	☎ 1577-8899
암생존자통합지지센터(지역암센터)	☎ 1577-9740
응급 119 · 정신건강 위기 109	

W2. 진료 기록지 (진료마다 1장)

항목	기록
날짜 / 진료과 / 의사	
오늘 들은 진단·병기	☒ /  / ?
오늘 결정된 것	
다음 검사·날짜	
다음 진료 날짜	
새로 받은 약	
꼭 지켜야 할 주의사항	
다음에 물어볼 것	

W3. 7일 증상 일지

날 짜	체온 (최고)	통증 0~10	식사(평소의 %)	배변· 배뇨	잠	기분 0~10	메모·연락 여부

W4. 복용 약·보충제 목록 (모든 진료에 지참)

이름	용량·횟수	왜 먹나	처방한 곳	의료진에 알림
				☐
				☐
				☐

이름	용량·횟수	왜 먹나	처방한 곳	의료진에 알림
				□

혈액을 묽게 하는 약(항응고제·항혈소판제), 당뇨약, 한약·건강기능식품은 수술·시술·항암 전에 특히 중요합니다.

W5. 30일 체크 달력

주	날짜	한 일(✅) / 남은 일(⌚)
1주(Day 0-7)		
2주(Day 8-14)		
3주(Day 15-21)		
4주(Day 22-30)		

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Non-Small Cell Lung Cancer / Small Cell Lung Cancer, Version 9.2026(비소세포 기준). NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 폐암 정보, 대한폐암학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 실지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).

- 참고문헌: 보건복지부 · 국립암센터 국가암지식정보센터, 폐암 정보(확인일 2026.10.04). 사실 확인용 참고문헌이며, 국가암지식정보센터의 저작물을 수록하지 않았습니다. 독자 안내: 공식 암 정보와 무료 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899.
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>